

Saúde e qualidade de vida de caminhoneiros

| **Elias Marcelino da Rocha**

| **Alice Manzano Deluci**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Rafael Leite de Almeida**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Cássio Soares Ribeiro**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Edson Antônio Silva Lima**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Luiz Felipe Petusk Corona**

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA

| **Vagner Ferreira do Nascimento**

Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

| **Alisséia Guimarães Lemesff**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

RESUMO

Este trabalho discute a temática “homem, saúde e profissão”. Identificamos em diversas pesquisas, a vulnerabilidade em alguns profissionais, em função de condições de trabalho, como os caminhoneiros, que pertencem a um grupo predominantemente masculino, que apresentam problemas relacionados às condições de saúde, devido ao trabalho e estilo de vida. Assim, a questão é qual o reflexo da profissão na saúde e qualidade de vida dos caminhoneiros? Objetivou-se verificar a saúde e a qualidade de vida dos caminhoneiros que trafegam a BR- 070. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa e como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado. A amostra foi constituída por 128 caminhoneiros, em um posto de combustível em Barra do Garças – MT, em 2019. A idade encontrada de 21 a 70 anos; 89,06%, trabalham entre 8 e 15h diárias; 64,06% estão a mais de 11 anos na profissão; 50 % consideram sua saúde boa; 53,90% relataram ter um bom sono; 47,65% consideram sua alimentação boa; 66,41% dos entrevistados afirmaram consumir bebidas alcoólicas; 25,78% deles fumam. Deste modo, os resultados evidenciam o pouco conhecimento sobre a própria saúde e os malefícios que a profissão pode resultar, são enormes, e indica a necessidade de sensibilizar a população masculina para a adoção de hábitos saudáveis de vida e prevenção de doenças. Espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de estratégias de educação em saúde voltadas para os caminhoneiros.

Palavras-chave: Motoristas, Saúde do Homem, Qualidade de Vida.

■ INTRODUÇÃO

Com o passar dos séculos, inúmeras descobertas foram feitas não somente sobre a vida, como também sobre a qualidade da saúde do ser humano. Entretanto, a figura masculina era vista na sociedade como o mantenedor, deixando a própria saúde de lado para que pudesse prover o sustento da família. O século XXI foi um período de transformação no que tange ao imaginário masculino, agora, que se preocupa com a própria saúde e busca novos hábitos que aumentem sua qualidade de vida (SOLANO *et al.*, 2017). Isso, também se soma a novas perspectivas de construção do conceito de gênero que se instala e passa a ser discutido na sociedade. Uma das definições dada é que, “o conceito de gênero – a construção social do que se entende por ser homem e por ser mulher – é uma ferramenta interessante para compreender o processo de socialização masculina” (LIMA, 2019).

Para alguns tipos de profissões predominantemente masculinas, o cuidado com a saúde pode ser ainda agravado pela rotina de trabalho e hábitos adotados, além da incompatibilidade com o atendimento das Unidades Básicas de Saúde. Os caminhoneiros são responsáveis por transportar as riquezas produtivas do país, através do transporte rodoviário, contribuindo para o desenvolvimento econômico, político e social do país (ROCHA, *et al.*, 2015).

Aproximadamente 1,8 milhões de caminhões compõem a frota brasileira e uma população de mais de 700 mil motoristas, quase que exclusivamente composta por homens, que trafegam em média 175 mil quilômetros anualmente (GUEDES *et al.*, 2010). Araújo e Oliveira (2020) complementa dizendo que o Brasil possui uma grande quantidade de veículos, e cada vez mais se observa um crescente aumento de sua frota automobilística, englobando caminhões, ônibus e carros.

O abastecimento das comunidades é de quase que total responsabilidade dos caminhoneiros, estes movimentam todo o território nacional a fim de manter os estoques das cidades de suprimentos necessários para a vida. O exercício da profissão e as metas levam os caminhoneiros a adotarem uma longa jornada de trabalho, percorrendo longas distancias, se alimentando de forma inadequada e tendo uma baixa qualidade de sono. A profissão requer muita responsabilidade, tomar conta da carga e de prazos de entrega; tem que se manter atento e paciente para as armadilhas das estradas, a fim de evitar acidentes (RESENDE; SOUSA; CERQUEIRA, 2010).

Alessi e Alves (2016) corroboram dizendo que este trabalho pode levar a prejuízos à saúde e pode também interferir no convívio social e familiar. Paris *et al.*, (2013), completa falando que a profissão interfere, nos hábitos alimentares, uso de álcool e anfetaminas para redução do sono e do cansaço, causam sedentarismo devido à extensa jornada de trabalho, pois ao dirigir demandam um gasto energético baixo, e não praticam atividades

físicas regularmente, o que aumenta os danos à saúde, com o aparecimento de diversas patologias, inclusive a obesidade.

A escolha entre ficar com a família e ir trabalhar para garantir o sustento do lar é diária. Os caminhoneiros têm que lidar com a distância e a saudade da família, pois a maioria deles opta pelo sustento do lar e um sentimento que dá forças para aguentar a saudade da família é o amor pela profissão e a liberdade conquistada. A fé e a religião são fatores que fazem parte da rotina dos caminhoneiros do Brasil, a fé é característica presente na vida desses profissionais que enfrentam todos os dias os desafios e as surpresas do trabalho autônomo (SILVA, 2015).

Em sua maioria, os motoristas não presenciam o nascimento dos filhos, tampouco acompanham o seu crescimento, visto que não possuem uma rotina diária de trabalho, não havendo ainda horário previsto para refeições e descanso, ou datas previstas para estar com a família. Na profissão eles convivem com a solidão nas estradas, buscando contato social de forma a suavizar o isolamento familiar e social (PEREIRA, *et al.*, 2014).

Os estudos apontam que os caminhoneiros possuem hábitos de vida nocivos à saúde, tais como alimentação não saudável, falta de atividade física, tempo insuficiente de descanso, vícios (cigarro e álcool), além do uso de drogas, exposição a doenças transmissíveis e da ausência de controle periódico em saúde (ALESSI; ALVES, 2016).

Estudos apontam que o trabalho dos motoristas de caminhão, no Brasil e em vários outros países, trazem problemas relacionados às condições de saúde, trabalho e estilo de vida, além de grande vulnerabilidade às práticas de risco, pelo uso de drogas. Tais problemas decorrentes das condições de trabalho e do estilo de vida afetam a saúde destes trabalhadores, tendo como referência à promoção à saúde (SILVA, 2015).

Silva (2015) ainda, complementa dizendo que a vulnerabilidade dos caminhoneiros ultrapassa o conhecimento científico, sendo um reflexo de onde eles vieram e de como é analisada a situação em se encermem, bem como analfabetos, ignorantes, ousados e abusados.

A partir do contexto de vulnerabilidade dos motoristas de caminhão, ainda em processo de entendimento, levando em conta a todos os fatores que são acometidos que colocam em risco a sua vida e saúde, surge a necessidade de aprofundar a discussão sobre a saúde do caminhoneiro e conhecer os aspectos peculiares da categoria para entender melhor esse contexto (PEREIRA, *et. al.*, 2014).

A necessidade de desenvolvimento de ações de educativas para a promoção e prevenção à saúde desses trabalhadores é evidente. É importante que estes sejam orientados com uma perceptiva ampla e abrangente da saúde, relacionando às condições e organização do trabalho a qualidade de vida. Esta promoção deve abranger trabalhadores, equipe multidisciplinar e a comunidade envolvida (HINO, *et al.*, 2017).

Contando com educação, visando sensibilizá-los sobre: a prevenção de acidentes, a redução do adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis, a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças infecciosas que podem ser prevenidas por vacinas (PEREIRA, *et al.*, 2014).

Devido às situações de riscos e a vulnerabilidade dos motoristas de caminhões, dá-se a importância do melhor conhecimento desta população, como forma de melhoria de qualidade de vida e saúde dos mesmos. Deste modo objetiva-se verificar a saúde e a qualidade de vida dos caminhoneiros que trafegam a BR- 070, mais especificamente, analisar a saúde, verificar o reflexo da profissão no estilo de vida dos caminhoneiros e analisar a percepção sobre saúde e qualidade de vida para poder compreender se, ser caminhoneiro é um fator de risco para o desenvolvimento de hábitos e estilo de vida não saudáveis interferindo assim na saúde e qualidade de vida dos mesmos.

Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa que investigou, e analisou a saúde e a qualidade de vida dos caminhoneiros. O estudo foi realizado com 128 caminhoneiros em 2019, no pátio de um posto de combustível, na cidade de Barra do Garças – MT, as margens da BR 0-70, local que apresenta um grande fluxo de caminhoneiros, que trabalham principalmente no transporte de grãos, pois esta região é riquíssima na produtividade de soja, milho, entre outros. A pesquisa foi realizada em um conjunto de ações desenvolvidas pelo projeto de extensão “Viva Bem Caminhoneiro”, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia (CUA).

A BR-070 é uma rodovia federal radial brasileira, também conhecida como Brasília/Cuiabá. A via se inicia em Brasília e termina no distrito de Corixá, município de Cáceres (MT), na fronteira com a Bolívia, passando pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás e Mato Grosso, perfazendo uma extensão de 1.317,7 km.



<http://hildodocandango.com.br/news/p:0/idp:1097/nm:Conheca-a-historia-da-BR-070/>

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado, desenvolvido por membros do projeto de extensão “Viva bem Caminhoneiro” da UFMT/CUA. Para este estudo fez-se um recorte do questionário para atingir os objetivos

propostos. Os caminhoneiros responderam ao questionário no início da atividade de extensão, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com tempo médio de 15 minutos para preenchimento.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso, sob número CAAE: 65604317.2.0000.5587 e protocolo nº 2.062.048, respeitando a Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Após a entrevista com o instrumento de coleta de dados, os mesmos foram analisados e tabulados pelo programa Epi Info versão 3.5.1, software criado pelo CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*, em português Centro para o Controle e Prevenção de Doenças), para assim ter uma visão mais clara e organizada dos dados coletados.

■ ESTILO DE VIDA DOS CAMINHONEIROS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como: “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”.

A saúde possui mais um valor da comunidade, que do indivíduo. É um direito que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica, sendo fundamental para a pessoa humana (ALVES e FONSECA, 2021).

Quando questionado sobre como consideram a sua saúde; 23,44% consideram ótima, 50 % consideram boa, 25,78% regular e 0,78% não respondeu. No senso comum, a definição de saúde ainda é algo que antecede as pesquisas da medicina, pois afirmam que a saúde é apenas a ausência de doença (ALVES e FONSECA, 2021).

A qualidade de vida dos trabalhadores está intimamente relacionada ao estilo de trabalho realizado, uma vez que este interfere diretamente nas condições de saúde do indivíduo. Fatores ambientais como sistema de turnos, privação de sono, horários irregulares e extensas jornadas de trabalho podem contribuir para danos físicos e mentais e gerar ainda acidentes de trabalho (LIMA, 2012).

Segundo Pinto Junior (2016), a falta de regulamentação da carga horária de trabalho dos caminhoneiros provocou abusos e desrespeito no que se refere à jornada de trabalho. À primórdio os empregadores tinham que recorrer à exceção do art. 62 I da CLT para recusar o pagamento de horas extras. No dia 30 de abril de 2012 foi aprovada a lei nº 12.619/2012, conhecida como a lei do descanso.

A precarização percebida nas primeiras impressões deixadas pela nova regulamentação da atividade do motorista profissional, veiculada por meio da Lei (nº 13.103/2015), deixa certo que o movimento social ainda não se estabilizou em situação de equilíbrio e razoabilidade. Concluída a movimentação legislativa, competirá ao Poder Judiciário comandar os próximos

movimentos, pois é na interpretação da regra legal e sua conformação com as diretrizes constitucionais que se conhecerá o “direito vivo” e seu efetivo alcance.

Entretanto, após movimentos sociais devido ao extremismo da Lei, foi estabelecida a lei nº 13.103/2015, para tentar manter um equilíbrio. Além da extensão da carga horária, menos rigorosa do que a lei anterior, outra inovação trazida pela Lei nº 13.103/2015 diz respeito à possibilidade de fracionamento do intervalo entre jornadas (PINTO JUNIOR, 2016).

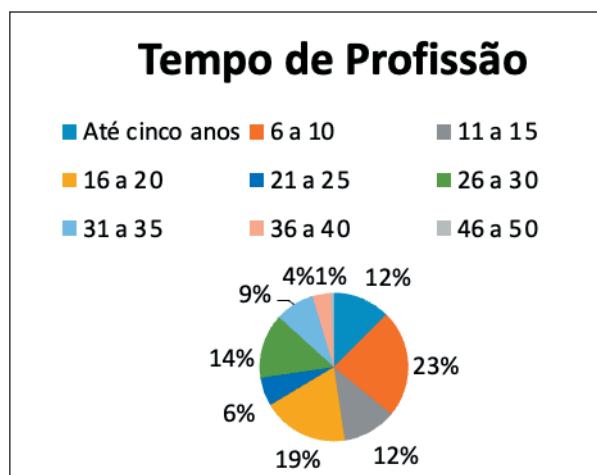
Nesta pesquisa observou-se que 89,06% trabalham entre 8 e 15h diárias e 5,47% trabalham mais de 15h diárias. De acordo com o Art. 235-C. da Lei nº 13.103/2015 e considerando apenas 2h extraordinárias, foi constatado que 48,44% dos caminhoneiros excedem a jornada de trabalho diária permitida.

Em 2015 foi constituído a Lei nº 13.103, estabelecendo que os caminhoneiros devem possuir 8h/dia de jornada de trabalho, respeitando um período de 11h/dia de descanso. Esta Lei como objetivo evitar acidentes nas rodovias e estradas do Brasil. O motorista não deve dirigir por mais de cinco horas interruptas. Esse tempo deve ser fracionado, pois a falta de atenção, cansaço e o sono, são um dos principais fatores de acidentes no trânsito. Estima-se que mais de 32% dos acidentes são ocasionados pela falta do descanso apropriado e cerca de 6% desses acidentes são fatais (GRACINDO; VICTORINO; CARVALHO, 2019).

Silva e Paz (2021), destacam que infelizmente grande parte dos motoristas de transporte de cargas enfrentam uma longa jornada de trabalho irregular, onde permanece acordado muitas das vezes mais que 18h/dia. Estudos demonstram que esse tempo de irregular reduz o desempenho psicomotor. Esses trabalhadores de turno irregular são geralmente motoristas de caminhão autônomo ou não assalariado que perfaz jornadas superiores a 12/14 horas em horários irregulares e em turnos diversificados para atender a demanda e o também e os prazo de entrega da carga, obtendo 4/6 horas de sono por dia (TAUBE; CARLOTTO, 2018).

Em relação à intensa carga horária, autores de uma pesquisa realizada em cinco municípios do Estado do Rio Grande do Sul notaram a junção de fatores como a ausência de oferta de serviços de saúde, de educação e poucas opções de lazer nos locais de parada, propiciam o consumo das anfetaminas (SINAGAWA *et al.*, 2015). A carga horária elevada produz desgaste físico e emocional buscando a solução no consumo de anfetaminas (KNAUTH *et al.*, 2012).

Gráfico 1. Distribuição dos caminhoneiros quanto ao tempo de profissão. Região Centro-Oeste, do estado de Mato Grosso, Brasil 2022. (n=128).



No que se refere ao tempo de profissão 23,44% dos entrevistados estão na profissão entre 6 a 10 anos, e 64,06% mais de 11 anos.

Em entrevista realizadas sobre segurança e saúde, por Narciso e Mello (2017), constatou que o tempo de serviço prestado na estrada pelos entrevistados é determinante na qualidade de vida. Araújo *et al.*, (2015) entrevistou 178 e obteve o resultado de 72,47% trabalham na profissão a mais de 10 anos. Faria *et al.*, (2015), obteve como resultado o tempo médio de 16,7 anos.

Cattani *et al.*, (2021) e Araújo *et al.*, (2015), afirmam que não existe uma relação direta sobre a profissão como causa de doenças, mas destacam uma relação entre a jornada de trabalho, idade e tempo de trabalho, como fatores predisponentes.

A irregularidade dos horários de trabalho é um ponto a ser analisado, este tem como consequência a adoção de hábitos alimentares não saudáveis, como o consumo de alimentos de alto valor calórico, fontes de lipídios, bebidas cafeinadas e alcoólicas. Um hábito bastante comum entre os motoristas é o uso de bebidas alcoólicas e anfetaminas para o alívio do sono, além do sedentarismo, fator esse que pré-dispõe a obesidade (PARIS, *et al.*, 2013).

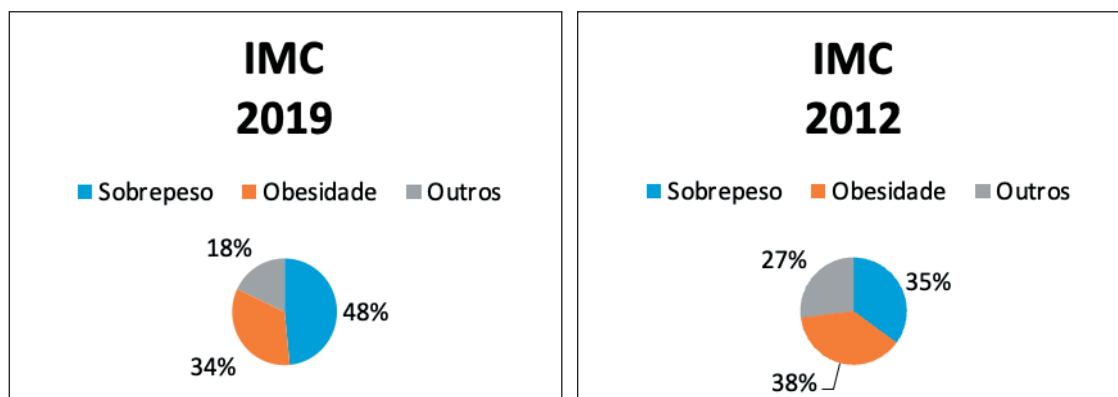
Quando questionado sobre o sono, 53,90% relataram ter um bom sono, 62% consideram seu sono regular e 7,03% ruim. “As mudanças na qualidade e nos horários do sono influenciam no apetite, a saciedade e a quantidade de ingestão de alimentos, favorecendo, assim, a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis” (PARIS, *et al.*, 2013).

Segundo Luiz e Teixeira (2016), essa diversidade de agravos da saúde dos motoristas profissionais tem um impacto negativo na sua qualidade de vida, entendida como um conceito amplo que abrange a complexidade de um construto social, cultural, subjetivo e multidimensional.

Em relação aos hábitos alimentares 47,65% consideram sua alimentação boa, quase 30% (28,12%) considera ter uma alimentação regular, e 10% uma alimentação ruim. Entretanto, depois de avaliado peso e altura foi possível realizar o cálculo do índice de

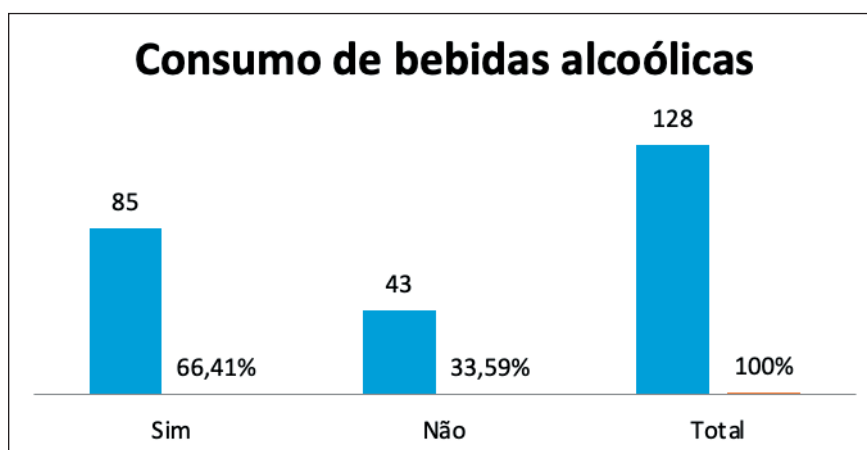
massa corporal (IMC) dos entrevistados, cuja fórmula é peso (kg) /altura (m²). De acordo com a OMS 48,44% apresentam IMC entre 25 a 29,9 (sobrepeso), 33,59 % > 30 (obeso).

Gráfico 2. Distribuição do Índice de Massa Corporal comparativo. Região Centro-Oeste, do estado de Mato Grosso, Brasil 2022. (n=128).



Em um estudo também realizado na cidade de Barra do garças em 2012, com o mesmo público alvo, foi obtido um resultado semelhante; normal 27%, sobrepeso 35% e foram considerados obesos 38% (ROCHA, *et al.*, 2015).

Gráfico 3. Consumo de bebidas alcoólicas. Região Centro-Oeste, do estado de Mato Grosso, Brasil 2022. (n=128).



No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas 66,41% dos entrevistados afirmaram consumir bebidas alcoólicas. Em estudo semelhante Santos, *et al.*, (2017) obteve o resultado de 73,9% e Belan, *et al.*, (2017) obteve a porcentagem de 65% e Junior Antoniassi, *et al.*, (2016) tem como resultado que mais de 29,67% dos caminhoneiros ingerem bebidas alcoólicas.

Os motoristas brasileiros apresentam grande consumo de cerveja e aguardente. A ingestão de bebida alcoólica além de ser uma das principais causas de acidentes, está diretamente relacionada a problemas de saúde (SANTOS, *et al.*, 2017).

Apesar de ser regulamentada por lei a proibição da venda de bebidas alcoólicas e anfetaminas em postos de combustíveis, existe a necessidade de campanhas para orientação e educação como forma de prevenção, e uma fiscalização nas estradas. Os caminhoneiros devem

ser alertados quanto aos riscos que causam o consumo dessas substâncias e sobre a dependência, visando melhorar a qualidade de vida desses profissionais (ALESSI; ALVES, 2016).

Apesar de uma estatística positiva em relação à quantidade de fumantes, é imprescindível relatar sobre o assunto devido aos malefícios do hábito em longo prazo. Várias são as estratégias de saúde pública para se chegar aos baixos índices de tabagistas, sendo essas estratégias modelos para os demais agravos à saúde.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema escolhido, apesar de não ser desconhecido é um tema pouco abordado. A promoção da saúde e prevenção de doenças no universo masculino ainda são pouco difundidas no meio científico quando comparado ao tamanho da problemática. É preciso conhecer o público alvo para atender as necessidades coletivas e individuais. Difundir o conhecimento através de educação em saúde é uma das maneiras de garantir esta estratégia direcionada na PNAISH.

A realização do estudo possibilitou entender um pouco mais sobre masculinidades e do exercício da profissão dos caminhoneiros, e demonstrou características peculiares destes trabalhadores. O longo tempo de profissão, as jornadas intensas de trabalho e os hábitos de vida pouco saudáveis são comuns entre eles.

Ademais, a entrada destes trabalhadores aos serviços da atenção básica ainda é baixa, visto que estes apresentam longas jornadas de trabalho que são incompatíveis com os horários de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, o que implica diretamente no seu processo de saúde e doença.

Vale ressaltar a importância do estabelecimento de estratégias em saúde da família, para a adesão dos serviços da atenção primária pelos caminhoneiros. É preciso conhecer mais as rotinas destes trabalhadores, e explorar pontos estratégicos, como os postos de combustíveis, postos fiscais e demais pontos de parada, principalmente no período noturno.

A enfermagem possui uma grande importância na disseminação do conhecimento e na busca por essas estratégias. É necessário que se trabalhe o acolhimento, e que seja criado vínculo com essa clientela, necessitando assim extrapolar a área hospitalar, centros de saúde e adentrar aos locais de trabalho dos caminhoneiros.

Espera-se que este estudo vá além de avaliar a saúde e a qualidade de vida dos caminhoneiros. Contribuindo também para que o desconhecimento dos fatores de risco, a falta de sensibilização, orientação e prevenção, os hábitos ruins, a baixa adesão na atenção básica, sejam um empecilho na saúde do homem.

■ REFERÊNCIAS

1. ALESSI, A; ALVES, MK. Hábitos de vida e condições de saúde dos caminhoneiros do Brasil: uma revisão da literatura. **Ciência & Saúde**, v. 8, n. 3, p. 129-136, 2016.
2. ALVES, CCM. FONSECA, RC. É um direito que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica, sendo fundamental para a pessoa humana. **Revista Jurídica Direito & Realidade**, v.9, n.13, p.1-26/2021.
3. ANTONIASSI JUNIOR G, et al. O uso de drogas por motoristas caminhoneiros e o comportamento de risco nas estradas. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**. Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 4, 2016.
4. ARAÚJO, ARM. OLIVEIRA, EC. Análise do consumo de combustíveis do setor de transporte rodoviário no Brasil. **Estudo & Debate**, Lajeado, v. 27, n. 3, p. 143-157, 2020.
5. ARAÚJO, TME et al. Prevalência da hipertensão arterial sistólica entre caminhoneiros que trafegam pela cidade de Teresina. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, v. 14, n. 1, 2015.
6. BELAN, TO. et al. Prevalência do uso de anfetaminas por caminhoneiros. **Revista Acta Biomedica Brasiliensia**, v. 8, n. 2. p. 71-82, 2017.
7. CATTANI AN, et al. Trabalho noturno, qualidade do sono e adoecimento de trabalhadores de enfermagem. **Acta Paul Enferm**. 2021.
8. FARIA KR, et al. Comportamentos de risco quanto ao Vírus da Imunodeficiência Humana entre caminhoneiros. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 23, n. 1, p. 27-32, 2015.
9. GRACINDO CV, VICTORINO SVZ, CARVALHO MDB. Condição de saúde de caminhoneiros em rodovias do Paraná. **XI EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica**, 1(1), 1-8, 2019.
10. GUEDES HM, et al. Fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial entre motoristas caminhoneiros. **Cogitare Enfermagem**, v. 15, n. 4, 2010.
11. HINO P, et al. Análise dos à saúde de caminhoneiro. **Revista de Enfermagem UFPE online**, Recife, v.11, n.11, p. 4741-4748, novembro, 2017.
12. KNAUTH DR, et al. Manter-se acordado: a vulnerabilidade dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul. **Rev Saúde Pública**. v. 46, n. 5, p. 886 893, 2012.
13. LIMA EMG, et al. Qualidade de vida no cotidiano de caminhoneiros e sua correlação com o cronotipo. **Dissertação de mestrado – Campinas**, 2012.
14. LIMA PL. Uma análise sobre a relação entre processos de socialização, identidade de gênero e consumo. **Dissertação de mestrado – UNISINOS**, 2019.
15. LUIZ CMM.; TEIXEIRA SC. Perfil nutricional de motoristas do noroeste paulista. **Unilago**, São Paulo, 2016.
16. NARCISO FV., MELLO MTD. (2017). Safety and health of professional drivers who drive on Brazilian highways. **Revista de Saúde Pública**, 51(26), 1-7.

17. PARIS P., GRANDI G., SIVIERO J., PEREIRA FB. (2013). Sono, estado nutricional e hábitos de vida de caminhoneiros. **Ciência & Saúde**, 6(3), 197-205.
18. PEREIRA FGF et al. Relação entre processo de trabalho e saúde de caminhoneiros. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 27, n. 4, p. 462-469, 2014.
19. PINTO JUNIOR AR. Considerações sobre a Lei n. 13.103/2015 e o exercício da atividade de motorista profissional. Rev. TST, Brasília, vol. 82, n 1, jan/mar 2016.
20. RESENDE PTV; SOUSA PR; CERQUEIRA PR. Hábitos de vida e segurança dos caminhoneiros brasileiros. 2010.
21. ROCHA EM. et al. Prevalência de obesidade e sedentarismo em caminhoneiros. **Interdisciplinar: Revista Eletrônica da UNIVAR**. N°.13 v.1 p.165 -169, 2015.
22. SANTOS MAS, et al. Uso de drogas por caminhoneiros que trafegam na rodovia BR-153. RMMG (**Revista Médica de Minas Gerais**), 2017.
23. SILVA LA; PAZ FAN. Fatores que podem influenciar na promoção da saúde do caminhoneiro: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14. 2021.
24. SILVA RA. Vida de caminhoneiro: Sofrimento e paixão. **Dissertação de mestrado. Puc-Campinas**, 2015.
25. SINAGAWA DM. et al. Association between travel length and drug use among Brazilian truck drivers. **Traddic Inj Prev**. 16, n. 1, p. 5-9, 2015.
26. SOLANO LC, et al. O acesso do homem ao serviço de saúde na atenção primária. **Revista de pesquisa cuidado é fundamental online**. 9(2): 302-308, 2017.
27. TAUBE ME e CARLOTTO MS. Diferenças de percepção de estressores de acordo com o tipo de rota no trabalho de caminhoneiros. **Aletheia**,51(1-2), 52-67, 2018.